



P R E S E N T A C I Ó N

Lineamientos de Convenios, Cobertura y Pertinencia Médica



Gerencia de Auditoría Médica,
Enfermería y Convenios
2026





1.Introducción



La validación de cobertura en pacientes asegurados requiere una **lectura correcta de convenios**, beneficios, condiciones de póliza y criterios de pertinencia médica.

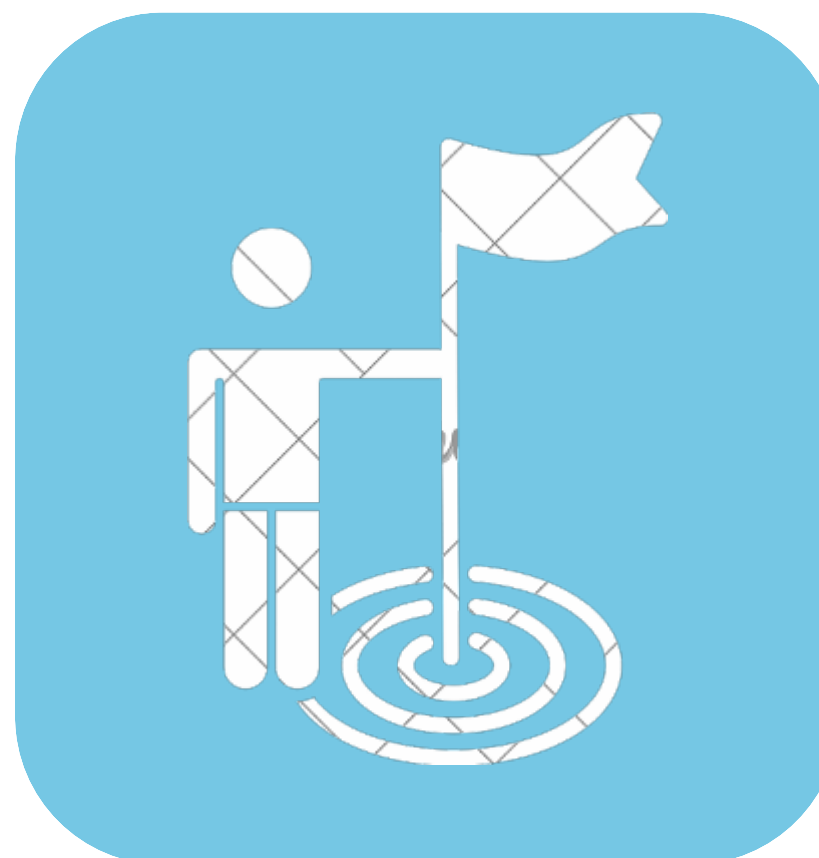
Esta capacitación está orientada a **fortalecer la gestión operativa del personal administrativo**, unificando criterios para una adecuada interpretación de cobertura, una correcta **orientación al usuario** y un oportuno escalamiento de casos.



2. Objetivos y alcances

Brindar criterios prácticos para la correcta validación de cobertura, fortaleciendo la interpretación de convenios, beneficios, condiciones de póliza y criterios de pertinencia médica en la gestión operativa diaria.

- Fortalecer la validación operativa de cobertura
- Unificar criterios de interpretación
- Revisar beneficios, exclusiones y topes
- Considerar observaciones de póliza y SITEDS
- Orientar el adecuado escalamiento de casos
- No reemplaza contrato, póliza ni evaluación clínica



3. Gobernanza de convenios

- **Convenios**
Define condiciones contractuales y tarifas por compañía.
- **Auditoría**
Revisa la pertinencia médica de la atención.
- **Administrativo**
Valida y comunica la cobertura al usuario según lineamientos vigentes.
- **Aseguradora**
Financia de acuerdo con plan, póliza y condiciones aplicables.



OBJETIVO COMÚN

Asegurar decisiones correctas y una orientación clara al usuario.





4.Cobertura vs pertinencia médica



La validación de una atención requiere distinguir entre **lo clínicamente necesario y lo contractualmente cubierto**.
 No todo lo pertinente tiene cobertura, y no toda cobertura aplica sin una adecuada indicación médica.

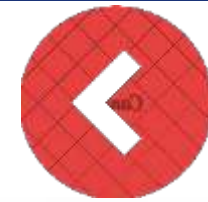
Elemento	Cobertura	Pertinencia médica
Enfoque	Contractual	Clínico
Pregunta clave	¿Lo paga el seguro?	¿Es médicamente necesario?
¿Qué evalúa?	Si la atención está financiada	Si la atención está médicamente indicada
Se basa en	Póliza, beneficios, exclusiones, topes, PEAS	Diagnóstico, indicación médica, evidencia clínica
¿Quién lo revisa?	Administrativo / Convenios / según lineamientos de cobertura	Auditoría médica
Resultado	Define si la prestación tiene cobertura	Define si la prestación tiene sustento médico



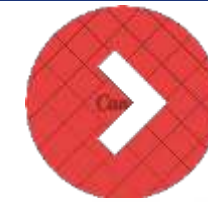
NO TODO LO PERTINENTE TIENE COBERTURA Y NO TODA COBERTURA APLICA SIN SUSTENTO MÉDICO



¿QUIÉN HACE QUÉ EN LA AUDITORÍA MÉDICA?



CONVENIOS



El auditor valida clínica y contractualmente, para que el administrativo decida la autorización con la información conjunta, aplicando las reglas de gobierno de Convenios.

Errores frecuentes



Errores del Administrativo



1. Aprobar solo porque está cubierto



2. No evaluar pertinencia médica



3. No escalar casos clínicos complejos



ZONA CRÍTICA

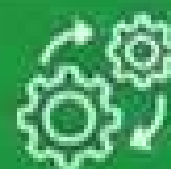
Nadie ve el caso completo
→ errores, sobrecostos y observaciones



Nadie ve el caso completo → errores, sobrecostos y observaciones



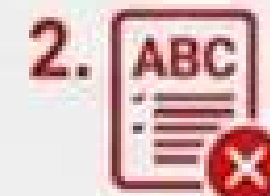
Forma correcta



Errores del Médico Auditor



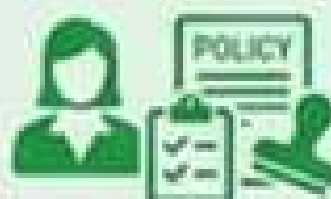
1. Evaluar solo lo clínico sin revisar cobertura



2. Desconocer condiciones del ABC



3. Aprobar prestaciones no cubiertas



1. Administrativo revisa cobertura



2. Auditor evalúa pertinencia

3. Ambos validan con ABC



5. Mecanismos de pago

Los mecanismos de pago **determinan la forma en que se financia la atención** y condicionan la validación de cobertura, la facturación y la participación del usuario.

➤ Costo Paciente Mes (CPM)

Asignación de un monto mensual convenido entre la compañía de seguros o financiador y la clínica para la atención ambulatoria del paciente en el mes, activado si se da la demanda de servicios.



La clínica presta atención médica (Ambulatoria y/o Emergencia) a un valor fijo sobre la totalidad de las atenciones, por cada persona diferente atendida en el lapso de 1 mes.

➤ Exclusiones del CPM (Ambulatorio)

- Atenciones de SCTR
- Atenciones Odontológicas
- Control del Niño Sano (CNS)
- Chequeos Médicos
- Diálisis
- Endoscopía terapéutica
- Control Pre-Post Natal
- Medicina Nuclear
- Tomografías, resonancias, radioterapias
- Procedimientos especiales invasivos
- Laboratorio de genética humana
- Atenciones oncológicas
- Litotricia extracorporea
- Atenciones por cirugía ambulatoria
- Atención domiciliaria
- Atenciones que requieran el uso del servicio de cirugía ambulatoria pre y post tto



➤ Paquetes Quirúrgicos

Mecanismo de pago no tradicional en el cual se definen previamente las patologías a incluir en el modelo, así como las características del mismo y los precios a pactar.



1. Días de habitación
2. Equipo de laparoscopia
3. Insumos
4. Perfil Pre-operatorio
5. Rayos X de Tórax
6. Riesgo Quirúrgico (RQ)
7. Sala de operaciones

8. Sala de operaciones
9. Patología
10. Cirujano principal
11. Asistente
12. Anestesiologo
13. Instrumentista
14. Materiales y medicina



> Dispositivos Electroquirúrgicos

**Ligasure, bisturí armónico
tijera armónica, enseal**



- Hepatectomía
- Colectomía total o parcial, otras resecciones intestinales
- Histerectomía, miomectomías, ooforectomía, anexectomía
- Esplenectomía
- Gastrectomía
- Nefrectomía
- Pancreatoduodenectomía
- Tiroidectomía abierta, paratiroidectomía
- Disección de cuello en oncología
- Mastectomía radical o total en oncología
- Hernia hiatal
- Linfadenectomía pélvica
- Funduplicatura de Nissen
- Adhesiolisis
- Neoplasias retroperitoneales



**Se rechaza en otras
indicaciones**

(hemorroidectomía,
apendicectomía,
colecistectomía, hernias
de pared de ninguna
clase, quistectomías, entre
otras)

Ej. Tarifa SEGUS

CONSTANTE

VARIABLE

Código	Prestación	Unid	Factor
10.02.09	Miomectomía uterina vaginal/abdominal parcial/total	141	?

Ej. de prestaciones (FxS)

- Honorario de procedimiento
- Ayudantías (01 y 02)
- Anestesiólogo
- Instrumentista
- Uso de SOP
- Sala de recuperación
- Medicamentos
- Laboratorio
- Patología
- Día de hospitalización
- Imágenes
- Insumos

Ej. de normas de facturación

- Anestesiólogo 30%
- Primer ayudante 25%
- Segundo ayudante 15%
- Instrumentista 6%
- Sala de operaciones 30%
- Día del alta no se cobra

Ej. Tarifa KAIROS

VARIABLE

Medicamento	PPS	DCTO.
Paracetamol 120mg/5ml	S/.5.17	?%

Ejemplo de tabla típica de negociación entre IPRESS y IAFAS privadas

Prestación	Tarifa
Factor honorarios	5.5
Factor exámenes auxiliares	5.5
Consulta	S/.45
Habitación	S/.350
UCI	S/.700
Descuento de Kairos	20%

- Las tarifas se negocian siempre sin IGV
- El factor de honorarios incluye cirugías, procedimientos médicos y ecografías
- El factor de exámenes auxiliares incluye laboratorio imágenes y patología
- A partir de la consulta se calcula consulta de emergencia, interconsulta, junta médica y visita en hospitalización
- La habitación por default es unipersonal
- Los insumos es a tarifario de la clínica

+ 6. Conceptos clave

Estos conceptos permiten **interpretar** de forma práctica las **condiciones de cobertura**, participación del asegurado y **restricciones aplicables** en la atención.



La correcta validación de cobertura

depende de identificar qué está cubierto, bajo qué condiciones y qué participación corresponde al asegurado.



> Copago

importe que debe asumir al asegurado por las atenciones de salud recibidas, puede ser un importe fijo o un porcentaje del gasto de las atenciones recibidas.

> Deducible

Importe fijo establecido en la póliza que el asegurado debe pagar directamente en la clínica.

> Coaseguro

Porcentaje establecido en la póliza que el asegurado debe pagar por los servicios recibidos (medicamentos, exámenes auxiliares, etc.) directamente en clínica.



> **Carencia**

Tiempo general en el cual el asegurado aún no puede hacer uso de sus coberturas de manera integral, de hacerlo tendrá restricciones.

> **Tiempo de Espera**

Periodo por el cual el asegurado debe esperar para atenderse por diagnósticos específicos.

> **Pre-existencia**

Diagnóstico o condición médica conocida o no por el asegurado antes de la inclusión a la póliza.

> **Latencia**

Beneficio de Planes Médicos que cubre al afiliado y a sus derechohabientes legales en caso de desempleo.

> **Carta de Garantía**

Es el documento de autorización de cobertura para el asegurado, tramitado por la clínica, evaluado y emitido por la aseguradora.

> **PEAS**

Plan Esencial de Aseguramiento en Salud
Listado Priorizado de condiciones asegurables.

> **Continuidad**

Es la exoneración de la carencia; se valida en el SITEDS (botón Observaciones).

> **Exclusión**

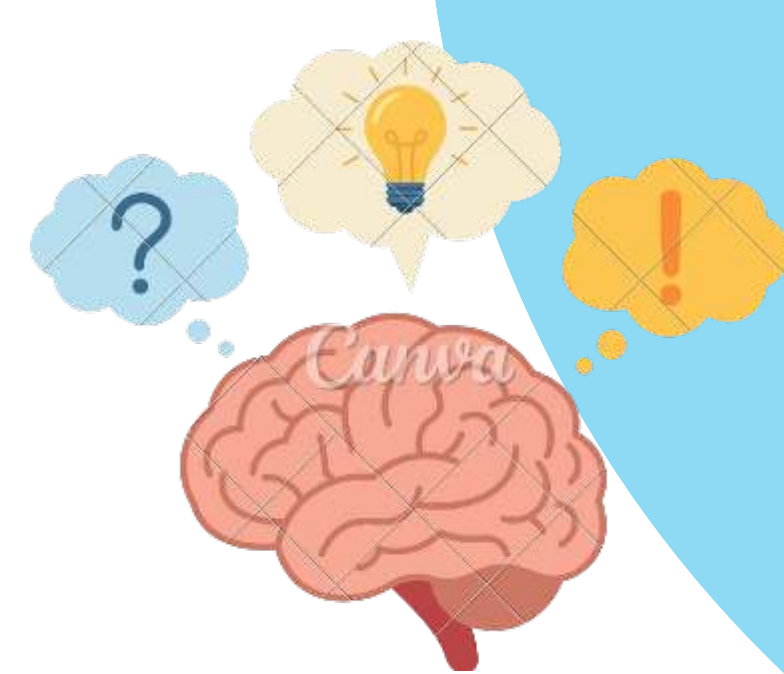
Diagnósticos o situaciones que no se cubren por políticas de la compañía.

> **Excepción a la exclusión**

Prestación que normalmente está excluída pero que puede ser financiada si cumple con determinada condición específica.

> **Gasto no cubierto/no financiado**

Es una prestación que no cuenta con cobertura según benefico o no cuenta con pertinencia médica.



> ¿Qué es una emergencia?

Aparición repentina de una alteración en la salud del asegurado, la cual se manifiesta a través de síntomas agudos de tal severidad que ponen en peligro su vida, integridad corporal o la viabilidad de alguno de sus órganos, por lo que requiere de atención médica inmediata.

Emergencia Médica

- Se brinda sólo en el servicio de emergencia
- Cobertura al 100% (puede variar según prestación)
- **No** hay continuación de emergencia médica.



Emergencia Accidental

- Cobertura al 100%
- Continuidad de 90 días (atenciones ambulatorias)
- La continuación se brinda en la misma clínica donde se atendió la emergencia.
- El paciente debe acudir por emergencia dentro de las 48 horas posteriores al accidente.
- No aplica la Continuidad de Emergencia Accidental para atenciones posteriores a una Hospitalización o Cirugía Ambulatoria a causa del accidente.

> Atención Hospitalaria

Las atenciones hospitalarias, sean o no programadas, terapéuticas o quirúrgicas requieren la emisión de una carta de garantía, se aplicarán los copagos fijos, variables y los topes que se hayan definido para este servicio según corresponda.

Control Post Hospitalario

- Para los controles post hospitalarios se aplicará el coaseguro indicado en SITEDS.
- Se consideran sólo los diagnósticos relacionados a la hospitalización y cirugías ambulatorias.
- Aplica hasta los 30 días contados a partir del alta del paciente.
- Las atenciones posteriores a los 30 días se atenderán bajo la cobertura ambulatoria.
- Aplica para hospitalizaciones para tratamientos quirúrgicos, médicos y cirugías ambulatorias.



> Programa Materno Infantil

Beneficio de Maternidad

- Se activa el beneficio cuando se cuenta con un examen de laboratorio positivo o estudio de imágenes confirmado.
- Sospechas de embarazo corresponden a una consulta ambulatoria.
- Se cubren dentro del control prenatal Infección urinaria, estreñimiento y vulvovaginitis

Tipo de Beneficio

- Controles Pre-natales
- Parto Natural y/o múltiple (Sujeto a Carta de garantía)
- Controles Post-Natales (2 controles dentro de los 45 días después del parto)
- Cesárea (Sujeto a Carta de garantía)
- Aborto No provocado (Sujeto a Carta de garantía)





➤ Programa Materno Infantil

Beneficio de Control de Niño Sano

- Consiste en conjunto de evaluaciones gratuitas con el pediatra según cronograma durante los primeros 11 años de vida - EPS Y AMF (Cobertura reflejada en Siteds).

Periodo	Frecuencia de consultas
Primero 28 días	1 consulta cada 15 días
Desde el 2 hasta el 12 mes de vida	1 consulta mensual
Durante el primer año de vida	1 consulta cada 2 meses
Entre el 2 año y el 4 año de vida	1 consulta trimestral
Desde los 5 hasta los 11 años de vida	1 consulta anual

Control de crecimiento y desarrollo (CRED)							
Hasta los 11 años de edad							
Procedimientos	RN (0 a 28 días)	29 días a < 1 año	1 año	2 años	3 años	4 años	5 a 11 años
Consulta pediátrica	2	11	6	4	4	4	1
Control de peso	2	11	6	4	4	4	1
Control talla	2	11	6	4	4	4	1
Control de maduración de órganos	2	11	6	4	4	4	1
Control de maduración de los sentidos	2	11	6	4	4	4	1

7. Terminología operativa en SITEDS

Sistema Integrado de Transacciones Electrónicas de Datos en Salud en Perú



SITEDS brinda información clave para la **validación de cobertura**. Su **correcta lectura** permite identificar beneficios, condiciones de póliza, restricciones y mecanismos de pago aplicables a la atención.



¿Qué revisar en SITEDS?	¿Para qué sirve?
Plan de salud	Identificar condiciones generales de cobertura
Beneficio	Confirmar qué prestación aplica
Observaciones de póliza	Detectar restricciones o condiciones especiales
Exclusiones / limitaciones	Reconocer prestaciones no cubiertas o condicionadas
Tope	Validar monto máximo de cobertura
Mecanismo de pago	Identificar forma de financiamiento o facturación



100



Ministerio de Salud

- Configurar
- Generar Acreditación
- Busqueda del Asegurado
- Cancelación de Atenciones
- Consulta Carta de Garantía
- Consulta y Reportes
- Herramientas



20001 - Rímac EPS - 00008744 - CLINICA ADVENTISTA GOOD HOPE

Acreditación del Asegurado - BÚSQUEDA DE ASEGURADO

LUCIA ANTONETTE KCOMY GROSCO
ROBERTO SALAS - Administrador EPS y No-asegurados

Identificación y Búsqueda del Asegurado

Seleccionar la EPS *

Rímac EPS

☐ Consulta al Registro de Afiliados al AUS - SUSALUD

SELECCIONAR APELLIDO PATERNO *

46726395

APELLIDO MATERNO

NO NOMBRES

BUSCAR ASEGURADO

Productivo	APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	Nombres	Parentesco	Contratante	Estado	Código del Asegurado	Fec. Nacimiento	Género
------------	------------------	------------------	---------	------------	-------------	--------	----------------------	-----------------	--------

CONSULTA DE REGISTROS DE ACREDITACIONES

Búsqueda general para ubicar IAFA

(*) Campo Obligatorio

- Configurar
- Generar Acreditación
- Búsqueda del Asignado
- Derivación de Atenciones
- Consulta Carta de Garantía
- Consulta y Reportes
- Herramientas

 [Conecta al Registro de Afiliados al RUS - SURGALUD](#)

RESEARCH DESIGN

CONSULTA DE RESULTADOS DE ACENTUACIONES:

▶ Campus Organizations

20001 - Elmas EPS - 00008746 - CLINICA ADVENTISTA GOOD HOPE

Acreditación del Asegurado - DATOS DEL ASEGURADO

INFORMACIÓN GENERAL

Nro. Subscritor	Código de asegurado	Nro. de documento anterior
	8862293	
Primer Curnombre	Segundo	Nro. entidad origen
00006473		
País		
PLACES MEXCOS		

DATOS DEL PACIENTE

Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno
LUCIA ANTONETTE	KCOMT	OROSCO
Edad	Fecha de nacimiento	Formulario
FEMENINO	20/03/1991	TITULAR
Tipo de Documento	Nro. Documento	Edad
DM	46726395	34
Fecha Expiración	Fin de vigencia	Estado civil
01/12/2016		SOLTERO
Plan de salud	Nro. Plan	Estado
PEAS + COMPLEMENTARIO	116635	ACTIVO

DATOS DEL PACIENTE SEGÚN EL REGISTRO DE AFILIADOS AL AOS DE SUSALUD

Nro. Subscritor	Buscar	Edad	Fecha de nacimiento
46726395			
País		Estado	
IPSS/Entidad			



Datos Adicionales

Condiciones Médicas

Observaciones

LISTADO BENEFICIOS

Buscar

Items por página: 25

Página 1 de 1

< >

Código	Beneficio	Restricciones	Copago Fijo	Copago Variable	Pln de Consulta	Costo Esperado
4100	CONSULTA AMBULATORIA	Ver Detalles	30.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 90.00%		
4505	AMBULATORIO POST OPERATORIO	Ver Detalles	0.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 85.00%		
4114	ENFERMEDADES EPIDEMICAS AMBULATORIAS	Ver Detalles	30.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 90.00%		
4400	DESASTRES NATURALES AMBULATORIO	Ver Detalles	30.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 90.00%		
4404	TANZAR NEONATAL	Ver Detalles	30.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 90.00%		
6101	EMERGENCIA ACCIDENTAL	Sin restricciones	0.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 100.00%		
6106	EMERGENCIA MEDICA	Ver Detalles	0.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 100.00%		
6401	CONTINUACION DE EMERGENCIA ACCIDENTAL	Sin restricciones	0.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 100.00%		
5700	PROCTOS QUIRURGICOS INTERNA	Sin restricciones	0.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 100.00%		
5201	NEUROESTIMULACION PARA PARKINSON	Sin restricciones	0.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 90.00%		
5206	HOSPITALARIO POR CIRUGIA	Sin restricciones	0.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 90.00%		
5101	HOSPITALARIO POR TRATAMIENTO	Sin restricciones	0.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 90.00%		
5114	ENFERMEDADES EPIDEMICAS HOSPITALARIAS	Sin restricciones	0.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 90.00%		
5400	DESASTRES NATURALES HOSPITALARIO	Sin restricciones	0.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 90.00%		
9000	PLANIFICACION FAMILIAR	Ver Detalles	30.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 90.00%		
4006	CONTROL PRENATAL	Ver Detalles	0.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 100.00%		
4008	ABORTO/AMENAZA DE ABORTO AMBULATORIO	Ver Detalles	0.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 75.00%		
5300	PARTO NORMAL	Sin restricciones	0.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 100.00%		
5301	ESARREA	Sin restricciones	0.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 75.00%		
5304	PARTO MULTIPLE	Sin restricciones	0.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 100.00%		
4007	CONTROL POST NATAL	Ver Detalles	0.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 100.00%		
4009	COMPLICACIONES EMBARAZO AMBULATORIO	Ver Detalles	0.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 75.00%		
5307	POCOPROFILAXIS DEL PARTO	Sin restricciones	0.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 100.00%		
5309	ABORTO NO PROVOCADO	Sin restricciones	0.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 75.00%		
5305	COMPLICACIONES EMBARAZO HOSPITALARIO	Sin restricciones	0.00 SOLES POR ATENCION	CUBERTO AL 75.00%		

IMPRIMIR AUTORIZACIÓN

AUTORIZACIÓN CONSULTA

CONSULTA DE REGISTROS DE
ACREDITACIONES

NUOVA BÚSQUEDA ASEGURADO

DATOS DEL PACIENTE SEGÚN EL REGISTRO DE AFILIADOS AL AUS DE SUSALUD

Nro. Documento

46736395



Género

FEMENINO

Fecha de Nacimiento

20/05/1991

Paciente

LUCIA ANTONETTE KCOMT OROSCO

Estado

ACTIVO

IPRESS Adjunta

Sin IPRESS adjunta para firmar EPS

DATOS DEL TITULAR

Nombre

LUCIA ANTONETTE

Apellidos

KCOMT OROSCO

Código titular

4862293

Tipo Documento

DNI

Nro. Documento

46736395

Moraleja

SOLES

Nombre de constituyente

ASOC. PASTORAL DE SERVICIOS MEDICO ASISTENCIALES GOOD HOPE O

Tipo documento constituyente

RUC

Tipo afiliación

REGULAR

Fecha de afiliación

01/12/2016

Nro. Documento constituyente

20337889167

Ministerio de Salud

SUSALUD
Sistema Único de Salud

40004 - Pacífico Seguro - 00008746 - CLINICA ADVENTISTA GOOD HOPE

LUCIA ANTONETTE KCOMT OROSCO
ADVENTISTA SALUD - Asociados PRES y No asociados

Configurar

Generar Acreditación

Búsqueda del Asegurado

Derivación de Atenciones

Consulta Carta de Garantía

Consulta y Reportes

Herramientas

Acreditación del Asegurado > BÚSCUEDA DE ASEGURADO

Identificación y Búsqueda del Asegurado

Selección de Afiliación:
Pacífico Seguro

☐ Consulta el Registro de Afiliados al AUI - SUSALUD

DIR. (IA DE CONSULTA INTERNA):
77002629

APELLIDO MATEANG

NOMBRES

BUSCAR ASEGURADO

Productos	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Parentesco	Contribuyente	Estado	Código del Asegurado	Fec. Nacimiento	Sexo
MULTISALUD	YBAÑEZ	MAYS	JOSELYN BRIGITTE	TITULAR	MAYS VELA JUDITH	VIGENTE	64003292	15-09-1995	FEMENINO

CONSULTA DE REGISTROS DE ACREDITACIONES

Campo Obligatorio

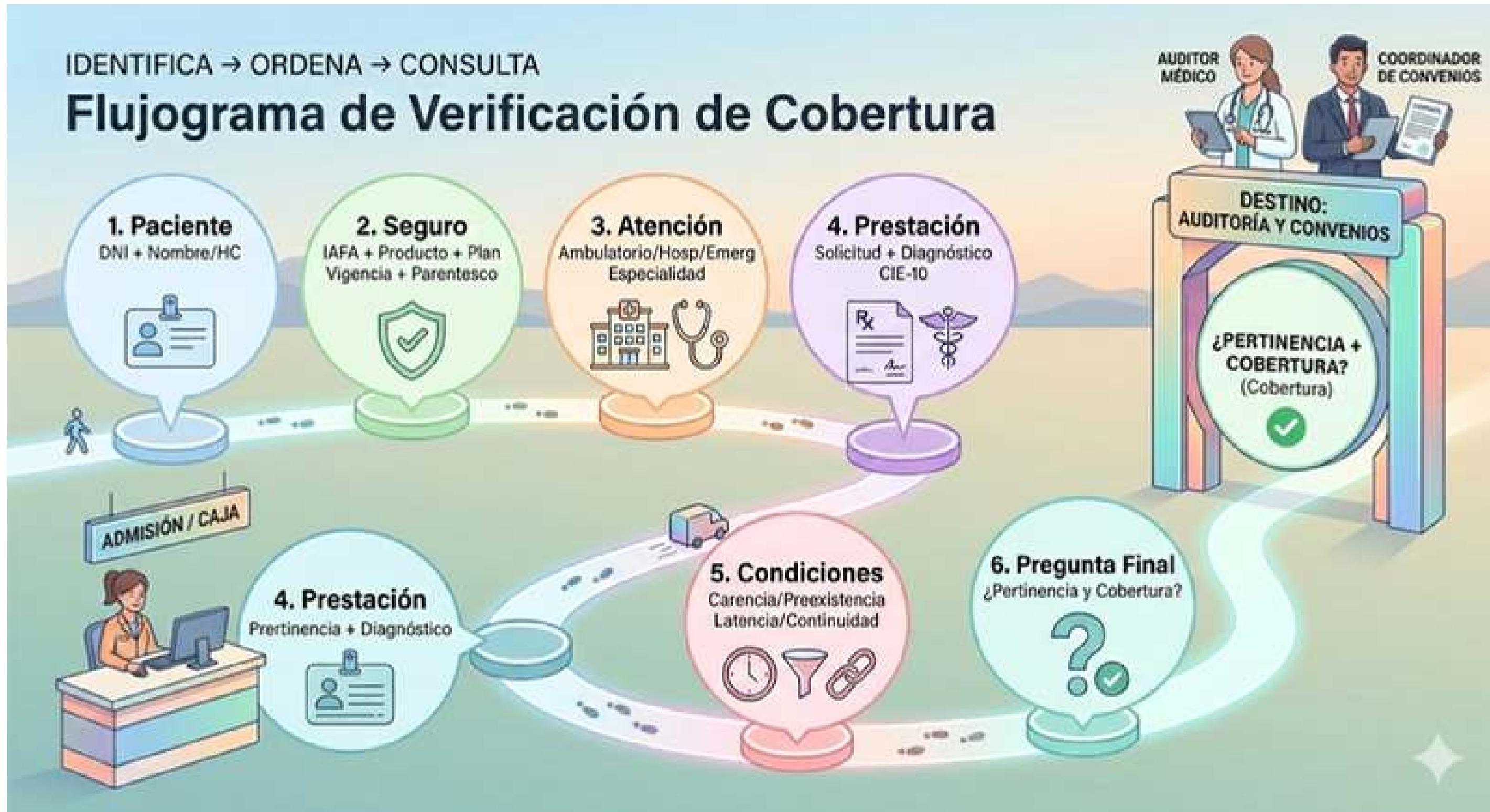


Producto	Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombres	Parentesco	Contratante	Estado	Código del Asegurado	Fec. Nacimiento	Género
SEGURO DE SALUD GRUPAL EMPRESAS	EZCURRA	YZAGUA	PEDRO OCTAVIANO	TITULAR	INSTITUTO DEL MAR DEL PERU	VIGENTE	64512604	13-11-1959	MASCULINO
MULTISALUD	EZCURRA	CALDERON	ALEJANDRO CARLOS	TITULAR	EZCURRA CANTOS TUPAC AMARU VLADIMIR	VIGENTE	63177658	15-10-1999	MASCULINO
MULTISALUD	EZCURRA	ZOEGER	VICTORIA MARIA MERCEDES	TITULAR	EZCURRA ZOEGER VICTORIA MARIA MERCEDES	VIGENTE	62939659	19-09-1943	FEMENINO
MEDICINA NACIONAL	EZCURRA	ROBLEDO	FLORENCIA ALMUDENA	TITULAR	EZCURRA ROBLEDO RODRIGO ALONSO	VIGENTE	62813513	18-11-2002	FEMENINO
MEDICINA INTERNACIONAL	EZCURRA	IRIAMONTI	AURELIO	HIJO NO INCAPACITADO	IRIAMONTI MANGINI MELVIA	VIGENTE	63708708	07-04-2019	MASCULINO
MEDICINA INTERNACIONAL	EZCURRA	IRIAMONTI	CAMILA	HIJO NO INCAPACITADO	IRIAMONTI MANGINI MELVIA	VIGENTE	63708707	08-02-2015	FEMENINO
SEGURO ONCOLÓGICO INDEMNIZATORIO TOTAL	EZCURRA	ANGULO	ALFONSO TERCERO	TITULAR	EZCURRA ANGULO ALFONSO TERCERO	VIGENTE	63373098	19-04-1977	MASCULINO
SEGURO ONCOLÓGICO INDEMNIZATORIO	EZCURRA	PACAYA	MILAGROS	TITULAR	EZCURRA PACAYA MARIA MILAGROS	VIGENTE	62958349	02-10-1989	MASCULINO

- **Condición Asegurable:** Es el estado de salud (ej. “Persona con hipertensión arterial”)
- **Prestación:** Es la unidad básica de atención (consulta, examen de laboratorio, cirugía) necesaria para tratar esa condición.
- **Cie-10:** Clasificación Internacional de Enfermedades



Ruta de consulta operativa de consultas complejas a Auditoría y Convenios





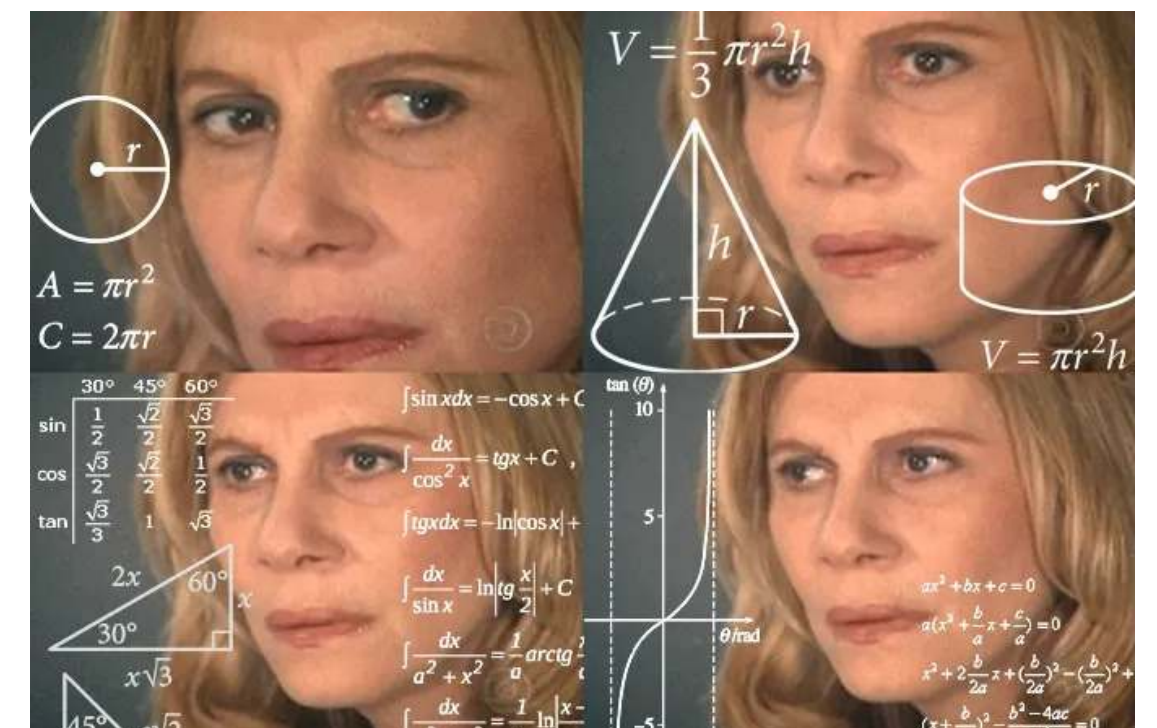
Quiero una hamburguesa con queso

No mejor quítale el queso

¿Y qué contiene la hamburguesa?

¿Puedo pagar con tarjeta?

¿Tienes yape?



"CUANDO HAS ESTADO EN LA MISMA LLAMADA 'URGENTE' DURANTE DOS HORAS".



"SOLO SIGUE SONRIENDO. TODO ESTÁ BIEN. (ELLOS NO PUEDEN VER EL GRITO INTERNO)".

9. Preguntas frecuentes



- **Cuántos días tiene un asegurado para poder reportar y atender su emergencia accidental?**
El EPS 48 hrs / SCTR: En Lima 5 días y en provincias 7 días / Accidentes personales 15 días / Accidentes de estudiantes 48 hrs
- **¿Cuántos días puede pasar un asegurado su control Post-Operatorio?**
El asegurado puede pasar con la cobertura “Ambulatorio Post Operatorio” hasta 30 días después del procedimiento / cirugía.
- **¿Qué necesita un asegurado para empezar sus atenciones oncológicas?**
Resultado anatomo patológico positivo / Tener cobertura oncológica / No tener tiempo de espera y/o carencia.
- **¿Cuánto tiempo tiene un asegurado para pasar las continuaciones de emergencias accidentales?**
EPS y Seguros 90 días calendario / SCTR hasta el alta del paciente / Accidentes personales y estudiantes hasta el tope de cobertura.
- **¿Cuántos días se cubren los controles Post-Natales?**
Se cubren 2 controles post natales dentro de los 45 días, después del parto

+ 8. PEAS Plan especial de aseguramiento en Salud

El PEAS establece un conjunto de condiciones e intervenciones en salud que forman parte del aseguramiento y **sirve como referencia para la revisión de cobertura dentro del plan de salud.**



Artículo 13°.- Plan Esencial de Aseguramiento en Salud

El Plan Esencial de Aseguramiento en Salud (PEAS) consiste en la lista priorizada de condiciones asegurables e intervenciones que como mínimo son financiadas a todos los asegurados por las instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, sean estas públicas, privadas o mixtas, y contiene garantías explícitas de oportunidad y calidad para todos los beneficiarios.



El PEAS orienta la revisión de cobertura, pero siempre debe leerse en conjunto con las condiciones específicas del plan y la póliza.



El PEAS no se autoriza por diagnóstico, se autoriza por prestación.



¿Qué es?	¿Qué debemos considerar?
Referente de prestaciones en salud dentro del aseguramiento	Revisarlo junto con póliza y plan vigente
Orienta la evaluación de cobertura	Considerar beneficios, exclusiones y topes
No reemplaza las condiciones contractuales	Aplicarlo con criterio operativo

110. Persona con diabetes mellitus no complicada

a) **Definición:** Es un trastorno crónico caracterizado por la presencia de niveles elevados de glucosa en sangre que puede estar producida por una deficiente secreción de insulina, una resistencia a la acción de la misma o una sinergia de ambas.

b) **Diagnósticos CIE-10:**

- E10.9 Diabetes mellitus tipo 1 sin mención de complicación
- E11.9 Diabetes mellitus tipo 2 sin mención de complicación
- E13.9 Otra diabetes mellitus especificadas sin mención de complicaciones
- E14.9 Diabetes mellitus, no especificada sin mención de complicaciones

c) **Contenido de las condiciones asegurables:**

Persona con diabetes mellitus no complicada				
Intervención	Prestación	Procedimientos médicos y sanitarios		Sustento Técnico
		Código del procedimiento	Denominación de Procedimientos	
Prevención	Procedimientos de laboratorio clínico	82947	Dosaje de Glucosa en sangre, cuantitativo (excepto cinta reactiva)	Según Resolución Ministerial N° 719-2015/MINSA, que aprueba la Guía Técnica: Guía de Práctica Clínica para el diagnóstico, tratamiento y control de la Diabetes Mellitus Tipo 2, en el primer nivel de atención

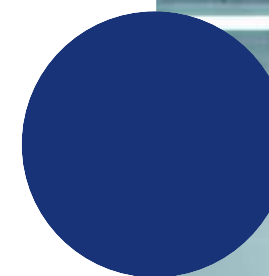
Radiología Convencional	71020	Examen radiológico de tórax, 2 incidencias, frontal y lateral
	73620	Examen radiológico, pie; 2 incidencias
Atención de procedimientos ambulatorios por médico especialista en cardiología	93000	Electrocardiograma, ECG de rutina con por lo menos 12 electrodos; con interpretación e informe
Consulta ambulatoria por médico(a) especialista en endocrinología, cardiología, nefrología, oftalmología, Consulta ambulatoria por médico(a) general	99203	Consulta ambulatoria para la evaluación y manejo de un paciente nuevo nivel de atención

Prevención secundaria de tuberculosis
Prevención secundaria de pie diabético
Prevención secundaria de enfermedad cardíaca
Incluye atención en oftalmología, endocrinología. En caso contar con especialistas en primer nivel de atención podrá realizarse la consulta. Prevención secundaria de

➤ Validador Pacífico



<https://validador-test.pages.dev>



8. Beneficios y coberturas especiales

Algunos beneficios presentan condiciones particulares de cobertura, por lo que requieren una validación más cuidadosa según plan, póliza, diagnóstico y condiciones vigentes.

> Oncológico

- Corte de cuenta a partir de la fecha de toma de muestra con resultado confirmatorio.
- Separación de gastos oncológicos desde el AP positiva en Carta de Garantía adicional (No aplica ampliación de CG inicial)

> Prótesis Quirúrgica

Monto total como beneficio máximo anual por persona, independientemente del tipo y cantidad de prótesis indicadas en base a plan / póliza vigente

> Maternidad

Cirugías simultáneas a las cesareas, bajo beneficio hospitalario de acuerdo a condiciones de plan /póliza



> Coberturas dependientes de beneficios

Las coberturas no son universales, sino que están ligadas a un beneficio específico.

- **Ejemplo 1 (Escitalopram):**

Dispone de cobertura bajo el beneficio de Salud Mental, pero no bajo el beneficio ambulatorio general.

- **Ejemplo 2 (Amoxicilina):**

Dispone de cobertura bajo el beneficio Ambulatorio, pero no bajo el beneficio de Control de Niño Sano.

> Necesidad médica ligada al diagnóstico

La necesidad médica (lo “medicamente necesario”) para exámenes auxiliares y tratamientos depende directamente de los diagnósticos.

- **Ejemplo:** La indicación de TSH y T4 libre es médicamente necesaria cuando se realiza para un estudio de disfunción tiroidea.

> Cobertura por excepción de la exclusión, dependencia del diagnóstico

Existen prestaciones que, aunque generalmente están excluidas, pueden financiarse dependiendo del diagnóstico específico.

Caso de estudio (Calcio y Vitamina D):

Ambos corresponden inicialmente a la lista de Exclusiones.

La Excepción: La exclusión señala una excepción cuando el diagnóstico es Osteopenia u Osteoporosis.

Resultado: Bajo estos diagnósticos específicos, se aprueba el financiamiento de la prestación.





“La Auditoria no es revisar cuenta, es proteger la sostenibilidad con criterio clínico contractual”

Dra. Cindy Tejada





Practice link

Click the link to join now.

 waygroundai





Gracias

Gerencia de Auditoría Médica,
Enfermería y Convenios

